

28.11.25

Иван получает медикаментозную терапию в течении полугода

В 2022 году на фоне релокации в другую страну, сначала Турция с друзьями, затем Сербия, где Иван задержался и долго был в одиночестве, на фоне чего злоупотреблял алкоголем ежедневно в течение полугода (около бутылки вина). Иван отметил безысходность, негативные убеждения о будущем, сниженную мотивацию. В июне 2025 года Иван меньше выпивал, впервые обращение к психиатру: эсциталопрам 10 мг + броназепам 1,5. эффекта не отметили, эсциталопрам увеличили до 15 мг, сероквель 25 мг. Крайне плохо переносился сероквель - чрезмерная сонливость на протяжении всего дня, тревога сохранялась больше даже из-за сонливости. Доктор предложил поднять до 100, Иван не согласился. Иван также отмечает что на фоне приема сероквеля не было совершенно положительных эмоций, сложно было сконцентрироваться. Очень сложно было оценить эффект от 15 мг эсциталопрама. 18 августа Иван самостоятельно отменил кветиапин, принимал 1 мг мелатонина. Стало чуть лучше, однако, Иван возобновил употребления алкоголя

Психиатр вводит ламотриджин до 75 мг, быстро возникла кожная аллергическая реакция, лам отменили. Сохранялась сонливость. Эсциталопрам перенесли на вечер, это не помогло. После этого замена на золофт до 50 мг, ощущения были еще хуже, через 10 дней Иван обратился с запросом на то, что от терапии упадок сил. В сентябре добавили к золофту броназепам. Усиливается тревога. Доктор меняет препарат на венлафаксин 75 по ¼ утром и вечером, увеличили до 150 мг, затем снизили до 112,5. Из побочных эффектов выраженная тошнота, добавили церукал. Несколько снизились депрессивные симптомы, стало позитивнее восприниматься будущее, но сохранялся выраженный упадок сил. Около 2х недель назад добавили вальпроат 300мг, на фоне чего началось выраженное нарушение сна - очень сложное засыпание; стало тошнить от алкоголя. Из вредных привычек курит сигареты, употребление ПАВ отрицает

Рост Ивана 190 см, вес 98. Увеличение веса за время приема антидепрессантов на 11 кг

Хронические заболевания: нет

Лекарственные препараты: роаккутан до начала 2025г

В н.в. Ивана **беспокоит**

- апатия
- сонливость
- отсутствие энергии
- тревога

HADS 6/10

Заключение: ведущими симптомами, которые мешают нормальному функционированию, являются симптомы депрессивного расстройства. Учитывая необычную высокую чувствительность к препаратам из группы СИОЗС (сертралин, эсциталопрам), даже в низких дозах, стоит продолжать очень медленно увеличивать дозу венлафаксина до норадренергической (225+). Надеемся на то, что влияние на обратный захват норадреналина поможет все таки преодолеть депрессивные симптомы. Также хочется отметить, что в таких ситуациях повышение дозы должно быть с небольшим шагом и длительным последующим наблюдением. Если удастся выйти на дозу 225 мг, я бы старалась понаблюдать на ней 2-3 месяца. Бывает что эффекта приходится долго ждать, а плохая переносимость не позволяет шагать с привычным нам диапазоном доз

Рекомендации

1) с 28.11.25 отмена вальпроата

2) венлафаксин

с 29.11.25 утром 1т +¼ табл (75+18,75)

вечером 1т (75)

с 05.12.25 утром 1т +¼ т (75+18,75)

вечером 1т +¼ т(75+18,75) = **187,5 мг в сутки**

3) по поводу веса не переживаем, позже скорректируем, сейчас острое состояние это депрессия

4) мелатонин 1 мг можно продолжать для коррекции нарушений сна

Удалось выйти на дозу 225 мг

12.01.26

Иван с 12.12.25 принимает 100 мг дезвенлафаксина утром. На фоне приема эпизоды легкого кружения, короткие, невыраженные, не мешают. Самочувствие утром и в обед стабильно, однако вечером становится хуже, чаще употребление легкого алкоголя. Состояние теперь больше тревоги, нежели депрессии. Стоит отметить, что добавились проблемы внешние, перерыв в психотерапии (3-4 недели)

В н.в. беспокоят

- тяга к курению и алкоголю, экскориации кожи пальцев на руках и ногтей (уровень тревожности возрос)
- чувство запутанности, нерешительности
- суицидальные мысли ежедневные очень легко, беглые
- настроение ровное, но бывают всплески хорошего настроения, чередуются с тревожными эпизодами, апатии поменьше существенно

Однако, последние две недели легче даются бытовые дела, уборка

Рекомендации:

Увеличить дезвенлафаксин до 150 мг в сутки в два приема: утро 100, вечер 50. Наблюдаем две недели, если эффект частичный, то меняем утро 50, вечер 100. Повторно встречаемся через 5-6 недель обсуждаем результат

Эффект оцениваем по вышеперечисленным жалобам

Отдельно попрошу наблюдать за эпизодами головокружений, есть ожидание что они

Обсудили про то, что затем стоит поговорить о симптомах СДВГ, определиться нужно ли медикаментозно корректировать, если они есть, и только потом заниматься вопросом отказа от курения (Максим Копылов, пульмонолог), и вопросами веса (Шапи)

11.02.26

Иван получает 150 мг дезвенлафаксина: 50 утро, 100 обед

Из хорошего:

- тревожность скорректировалась
- грызение и эксфолиации прекратились

Из плохого:

- ничего не хочется
- тяга к алкоголю сохраняется
- упадок сил, сложно заставить себя

Шкала Бека 15 (7/8)

Бернс 59

цунг 55/69

Оземпик с 27.01. 0,25, снизили до 0,125 из-за плохой переносимости, затем пару дней как перешли вновь к 0,25

Рекомендации

- 1) продолжаем дезвенлафаксин 50 утро, 100 обед
- 2) ламотриджин (ламиктал)
 - 1 неделю 25 мг вечером
 - 2 неделю 50 мг
 - 3 неделю 75 мг
 - с 4ой недели и далее 100 мг

при нормальной переносимости можно ускориться с наращиванием дозы, настороженность на кожные реакции, при появлении сыпи сразу связаться и не продолжать прием препарата до обратной связи от меня

14.02.26 связь в чате

Алкоголь не уходит, за это очень переживаю. Дошел до 100 ламотриджина, особо ничего не происходит, только 1 день что-то было сильно, но настроение получше, а вот вечером совсем тяжело. Подскажите, пожалуйста, как поступить, сил 0. Но тревоги особо нет, все еще, тут все получилось

с 15.02.26 ламотриджин 150 мг

с 18.02.26 ламотриджин 200 мг (самостоятельно)

24.02.26 связь в чате

Хадс 2/11

Бек 16 9/7

Бернс 51

“Еле работаю и тяжело что-то менять в жизни, хочется только спать. Кажется совсем не могу работать и это прям сказывается на качестве жизни”

05.03.26 связь в чате

“Анна, здравствуйте! Простите ради бога. Переживаю — мыться даже стало очень тяжело. Такого еще не было. Я подозреваю, что еще внешние факторы сильно ухудшились”

Здравствуйте, сочувствую что так (но ещё мало времени прошло чтобы говорить о неэффективности

Давайте так

Поднимаем ламотриджин до 200

Дезвенлу 200 оставляем и нам надо хотя бы до конца марта смотреть

В идеале до начала апреля

27.03.26 встреча

- 1) убираем ламотриджин полностью
- 2) дезвенлафаксин снижаем до 100 мг с 27.03.26
- 3) наблюдаем
 - тревожность (не возрастает ли)
 - депрессивные симптомы - не появляются ли силы и мотивация
 - курение сигарет не полностью, одна за одной, тяга к алкоголю, продолжать играть в компьютерные игры
- 4) 15 апреля связь, обсуждаем топирамат

03.04.26 связь в чате

Дезвенлафаксин

с 04.04.26 50 мг

с 05.04.26 отмена

Велбутрин 150 медл высв

с 04.04.26 150 утром

с 10.04.26 и далее 300 утром

Топамакс 25 мг начинаем только когда поймем что хорошо переносится велбутрин

1-4 день 25 мг

5-8 день 50 мг

с 9го дня и далее 100 мг

Не торопимся! Он противный

01.05.26

передозировка АД (серотониновый синдром?) на фоне приема велбутрина 150 и дезвенлафаксина 100, ошибочно двукратный прием купирован ондасетроном 16 мг в сутки

Велбутрин возобновили с 10.04. 150 мг 2 табл утро

Из положительных изменений

- появилось желание что-то делать
- возобновился спортзал
- смена работы в течение недели на более оплачиваемую
- прием алкоголя контролируемый, все это время отказ
- сон нормализовался, вероятно с появлением энергии

Из негативных моментов

- грызение ногтей
- сохраняется тревога
- сложно проснуться утром, сил мало, но ранний прием препарата помог быть более бодрым
- последнее время эффект пошел на спад - стало требоваться больше усилий чтобы заставить себя, но при этом сон становится все лучше

- раздражительность, вплоть до гнева, особенно сильно если пропуск приема пищи утром. Такое не характерно для Ивана - не импульсивный. Эпизоды рандомные
- аппетит возрос (купирование тревоги?)
- грусть, много слез с 5го дня приема

Рекомендации

1) разделяем на 2 приема 150 утро, 150 вечер
наблюдаем

- станет ли утром бодрее
- не порушится ли сон
- не стало ли меньше злости

2) Также нам нужно оценить терапевтический эффект в отношении

- тревоги
 - депрессивных симптомов
 - не пройдет ли злость, импульсивность, слезы и переедание
- через 3 недели оценим нужен топамакс

3) в конце мая повтор